



INSTITUTO DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL
SÍRIO-LIBANÊS



PROTOCOLO INSTITUCIONAL

Protocolo de Sepses Ref HRRB_PRO 034

Identificação, Abertura e Manejo Assistencial

A sepsis representa uma **emergência clínica tempo-dependente** que exige reconhecimento imediato e ação coordenada da equipe multiprofissional. Cada minuto de atraso no diagnóstico e tratamento está diretamente associado ao aumento da mortalidade hospitalar.

Este protocolo institucional padroniza as condutas assistenciais, reduz falhas no processo de cuidado e estabelece diretrizes claras para toda a equipe. O protocolo deve ser **aberto diante da suspeita clínica**, sem aguardar confirmação laboratorial definitiva.

Elaboração:

Dra. Mariana - Coordenadora Médica

Qualidade Performa Saude



IDENTIFICAÇÃO

Quando Suspeitar de Seps

A suspeita de seps deve ser considerada em todo paciente que apresente **infecção suspeita ou confirmada**, associada a sinais de resposta inflamatória sistêmica (SIRS) e/ou disfunção orgânica aguda.

 **Princípio fundamental:** Não aguardar confirmação laboratorial para iniciar o protocolo. A suspeita clínica é suficiente para abertura imediata.

1

Identificar Critérios

- Dois ou mais critérios SIRS
- OU pelo menos um critério de disfunção orgânica

2

Notificar Imediatamente

- Comunicar o enfermeiro responsável
- Iniciar preenchimento da Ficha do Protocolo de Seps

3

Comunicar Médico

- Avisar o médico assistente com prioridade

Registro no Sistema PEP



Acessar PEP

Prontuário Eletrônico do Paciente



Localizar Paciente

Buscar paciente com suspeita de seps



Escalas e Índices

Selecionar HRRB e unidade de internação



Score Flex

Adicionar "Avaliação inicial SEPSE"

Critérios de SIRS

A presença de **≥ 2 critérios** indica resposta inflamatória sistêmica:

- Temperatura $\geq 38,3$ °C ou $\leq 36,0$ °C
- Frequência cardíaca ≥ 90 bpm
- Frequência respiratória ≥ 20 irpm ou $\text{PaCO}_2 < 32$ mmHg
- Leucócitos $> 12.000/\text{mm}^3$, $< 4.000/\text{mm}^3$ ou $> 10\%$ de bastonetes

SIRS isolado não confirma sepse, mas quando associado à infecção exige abertura imediata do protocolo institucional.

Disfunção Orgânica

A presença de **qualquer sinal** abaixo caracteriza sepse até prova em contrário e exige abertura imediata do protocolo:

Cardiovascular

- PAS < 90 mmHg ou PAM < 65 mmHg
- Queda da pressão habitual
- Necessidade de vasopressores
- Perfusão periférica reduzida

Respiratória

- $\text{SatO}_2 \leq 90\%$ em ar ambiente
- Necessidade de oxigenoterapia
- Relação $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ reduzida
- Ventilação não invasiva ou invasiva

Neurológica

- Confusão mental ou delirium
- Rebaixamento do nível de consciência
- Glasgow < 15

Renal

- Diurese $< 0,5$ mL/kg/h
- Oligúria ou anúria recente
- Elevação aguda da creatinina

Hepática

- Elevação de bilirrubina
- Alteração de enzimas hepáticas
- Icterícia de início agudo

Hematológica

- Plaquetopenia
- Alterações de coagulação
- Sangramento espontâneo

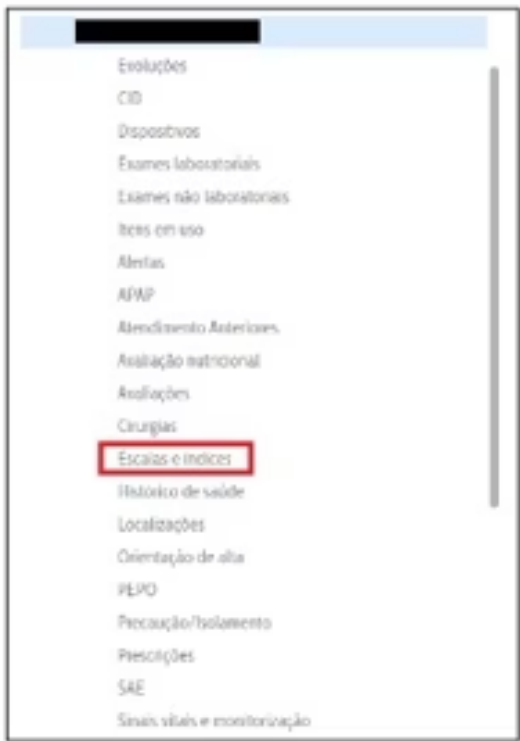
Metabólica

- Lactato elevado - Acidose metabólica - Hiperglicemia não explicada - Hipotermia associada à infecção

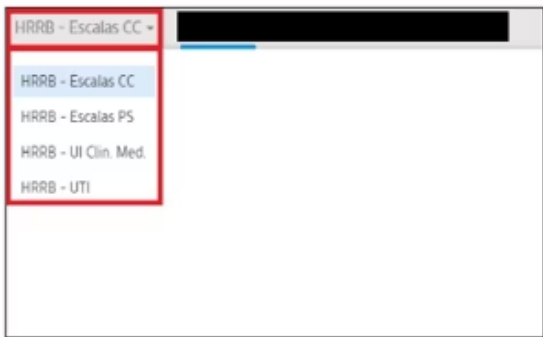
Avaliação Médica no Tasy

Acesso ao Sistema

- 1-Acessar o Prontuário Eletrônico PEP.
- 2- Localizar o Paciente - O prontuário sinalizará um alerta de segurança.
- 3. Clicar no menu "Escala e Índices".



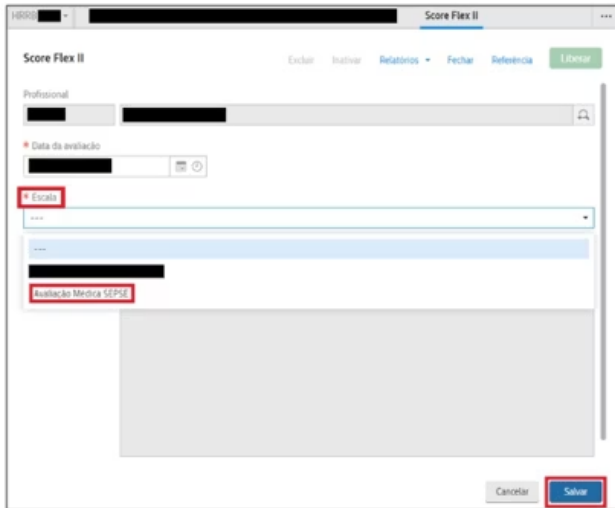
- 4 . Selecionar HRRB e a unidade de internação correspondente.



- 5. Clicar em "SCORE Flex" e, em seguida, em "Adicionar".

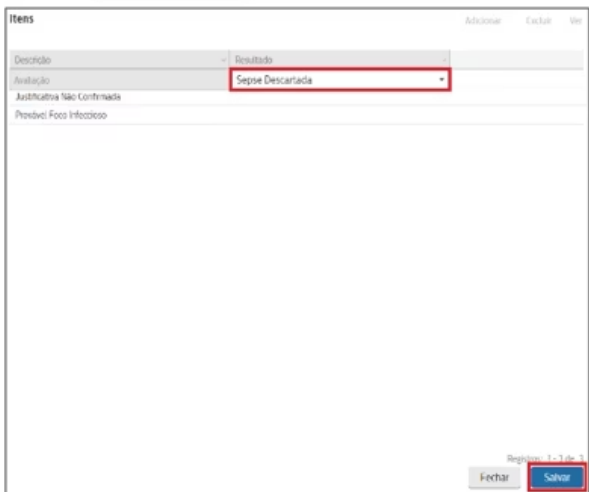


- 6. Em "Escala", selecionar a opção "Avaliação médica sepse" e salvar.



- 7. Após, será possível completar as informações de acordo com a avaliação médica.

- 8 . Caso o profissional médico não concorde com a abertura do protocolo de sepse, no campo "Avaliação", selecionar a opção "Descartar", salvando em seguida. No item "Justificativa", selecionar o motivo do encerramento do protocolo de sepse, salvar e liberar. O protocolo será imediatamente finalizado.



Resumo: Avaliação Clínica e Decisão Clínica

Avaliar clinicamente e confirmar ou descartar sepse após exame objetivo.

Score Flex II Menu Escalas e Índices → Adicionar "Avaliação médica SEPSE"



Sepse Descartada

- Selecionar "Descartar" no campo "Avaliação".
- Escolher justificativa: "Palição", "Protocolo Específico" ou "Sem Infecção".
- O protocolo será finalizado imediatamente.



Sepse Confirmada

- Indicar: "Sepse Provável" ou "Choque Séptico".
- Preencher "Provável Foco Infeccioso" com o sítio suspeito.
- Liberar para gerar assinatura médica.

✓ SEPSE CONFIRMADA

Sepse Confirmada

Após avaliação médica, deve-se fazer a avaliação indicando se sepse provável ou choque séptico e colocar o provável sítio suspeito, salvar após cada ação.

1- Após avaliação médica, deve-se fazer a avaliação indicando se sepse provável ou choque séptico e colocar o provável sítio suspeito, salvar após cada ação.

11. Tendo sido preenchida a "Avaliação" e o "Provável Foco Infeccioso", clicar em "Liberar".

2- Confirmada a suspeita de sepse, acessar prescrições para incluir condutas terapêuticas e exames laboratoriais

3- Clicar em novo e selecionar opção protocolos

4- Preencher opção Protocolo com protocolo sepse e selecionar o foco do suspeito da sepse em subtipo protocolo

5- Após clicar em selecionar todos para incluir automaticamente o antibiótico preconizado e os exames recomendados, conferir os itens da prescrição e depois liberar os itens



Registro e Evolução do Protocolo

Até a liberação do sistema, a evolução deverá ser realizada em notas clínica seguindo os itens abaixo:

1

Abertura do Protocolo

- Data e horário da abertura do protocolo de sepse
- Foco provável

2

Exames Laboratoriais

- Data e horário da solicitação da hemocultura
- Data e horário da coleta da hemocultura
- Data e horário da solicitação do 1º lactato
- Data e horário da coleta do 1º lactato

3

Antibioticoterapia

- Data e horário da prescrição do antibiótico
- Data e horário do início da administração do antibiótico

4

Avaliação Médica

- Data e horário da avaliação médica
- Classificação do quadro (sepse/choque séptico)

5

Intervenções

- Indicação de expansão volêmica?
- Data e horário da expansão volêmica
- Volume de expansão volêmica realizado
- Indicação de droga vasoativa?
- Data e horário do início da droga vasoativa

6

Desfecho

- Necessidade de transferência para UTI?
- Profissionais envolvidos na abertura e na condução do protocolo

Rx PRESCRIÇÃO

Prescrição de ATB e Exames

APÓS CONFIRMAR SEPSE NO SCORE FLEX II, seguir os passos abaixo. ESSA ETAPA É BEM IMPORTANTE.

1

Menu Prescrições

Ir para a PRESCRIÇÃO.
No canto superior direito,
clique em "ADICIONAR
NOVO" e depois
"PROTOCOLOS".

2

Adicionar Protocolos

Selecionar a opção de
adicionar protocolos no
sistema.

3

Escolher Protocolo e Foco

- Escolher primeiro "PROTOCOLO SEPSE"
- Depois em "SUBTIPO DE PROTOCOLO" escolher o FOCO da INFECÇÃO
- Os Antibióticos padronizados para o foco escolhido já serão incluídos automaticamente

4

Liberar Itens

- Além dos ATBs, também já serão incluídos automaticamente os exames padronizados para o "Kit Sepsis"
- Confirmar inclusão na prescrição → "LIBERAR"



💧 REPOSIÇÃO VOLÊMICA

Indicações de Reposição Volêmica Imediata

Iniciar **imediatamente** na presença de sinais de choque séptico:

PAS < 90 mmHg
Pressão arterial sistólica baixa

PAM < 65 mmHg
Pressão arterial média reduzida

Queda ≥ 40 mmHg
Redução da pressão habitual

Lactato Elevado
> 2 vezes o valor de referência

- Reposição volêmica se choque
- Cristaloide 30 mL/kg na primeira hora
- Monitorização contínua

Antibioticoterapia por Foco Infeccioso

INFECÇÕES COMUNITÁRIAS	
Foco da sepse/ choque séptico	Antibioticoterapia padronizada
Pneumonia	Amoxicilina + Clavulanato 1g, via EV, a cada 08 horas.
Trato urinário	Ceftriaxona 1g, via EV, a cada 12 horas.
Sistema nervoso central	Ceftriaxona 2g, via EV, a cada 12 horas.
Intra-abdominal	Ciprofloxacino 500mg, via EV, a cada 12 horas + Metronidazol 500mg, via EV, a cada 08 horas.
Pele e partes moles	Ceftriaxona 1g, via EV, a cada 12 horas + Clindamicina 600mg, via EV, a cada 08 horas.

COBERTURA DE GRAM-POSITIVO NA NEUTROPENIA FEBRIL
Suspeita de infecção relacionada ao cateter venoso central (CVC)
Mucosite grave (graus II e IV)
Infecção de pele e partes moles
Suspeita de pneumonia por gram-positivos
Hemoculturas positivas para gram-positivos
Colite pseudomembranosa
Colite pseudomembranosa (enterocolite neutropênica)
Colonização ou infecção prévia confirmada por Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) e/ou por Enterococcus resistente à beta-lactâmicos.

INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE	
Foco da sepse/ choque séptico	Antibioticoterapia padronizada
Pneumonia	Piperacilina-Tazobactam 4,5g, via EV, a cada 06 horas.
Trato urinário	Piperacilina-Tazobactam 4,5g, via EV, a cada 06 horas.
Intra-abdominal	Vancomicina 20-25mg/kg, via EV, a cada 12 horas + Piperacilina-Tazobactam 4,5g, via EV, a cada 06 horas.
Sistema nervoso central	Vancomicina 20-25mg/kg, via EV, a cada 12 horas + Meropenem 2g, via EV, a cada 08 horas.
Pele e partes moles	Vancomicina 20-25mg/kg, via EV, a cada 12 horas + Piperacilina-Tazobactam 4,5g, via EV, a cada 06 horas.
Osso	Piperacilina-Tazobactam 4,5g, via EV, a cada 06 horas.
Neutropenia febril	Piperacilina-Tazobactam 4,5g, via EV, a cada 06 horas.

Metas do Protocolo de Seps

Garantir **reconhecimento precoce**, **tratamento oportuno** e **redução da mortalidade** por seps e choque séptico, por meio da **adesão rigorosa ao protocolo institucional**.

Metas assistenciais



Reconhecer e abrir o Protocolo de Seps

imediatamente após suspeita clínica



Administrar antibiótico empírico adequado

em até 60 minutos



Iniciar ressuscitação volêmica precoce

quando indicada



Assegurar monitorização contínua

e reavaliações seriadas



Garantir registro completo

e rastreável em prontuário

Indicadores de Processo

(Avaliam a execução do cuidado)

Taxa de adesão ao Protocolo de Seps

% de pacientes elegíveis com protocolo corretamente aberto

Antibiótico na primeira hora

% de pacientes que receberam antibiótico em até 60 minutos

Conformidade da coleta de hemoculturas

% de hemoculturas coletadas antes do antibiótico

Tempo de liberação do lactato sérico

Tempo médio entre identificação e resultado

Meta: ≤ 60 minutos

Adesão ao Bundle da 1ª hora

% de pacientes com todas as medidas realizadas na primeira hora

Registro em prontuário

% de casos com documentação completa e adequada



Resumo: Abertura e Condução do Protocolo



Enfermagem

Identificação e Abertura

- Identificar critérios de sepse
- Comunicar enfermeiro responsável
- Preencher ficha do protocolo
- Avisar médico com prioridade
- Abrir protocolo no sistema Tasy
- Registrar Avaliação Inicial – Sepse (Score Flex)



Avaliação Médica

Decisão e Classificação

- Avaliação clínica completa
- Registro em Score Flex II
- Decisão: sepse descartada → encerrar protocolo
- Sepse confirmada → classificar gravidade
- Definir foco infeccioso provável
- -Assinatura médica obrigatória



Tratamento Inicial

Antibiótico + Ressuscitação

- Antibioticoterapia em até 1 hora
- Escolha conforme foco e protocolo
- Reposição volêmica se choque
- Cristaloide 30 mL/kg na primeira hora
- Monitorização contínua

A adesão rigorosa a este protocolo é fundamental para salvar vidas. Cada minuto conta no tratamento da sepse. Trabalho em equipe, comunicação efetiva e ação rápida são essenciais para o sucesso do cuidado.

Confirmação de Treinamento

Sua participação é **essencial e obrigatória**. A adesão aos treinamentos fortalece nossa equipe e garante a segurança do paciente.

Registre sua participação agora clicando no link.

<https://forms.gle/18dxSJjB89imzXvE6>